

전립선 비대 (BPH)

WARWIKI

환자 안내문 · 소변 증상이 생기는 이유와 치료 방법

전립선비대증(BPH)은 나이가 들면서 전립선이 비암성으로 커지는 매우 흔한 질환입니다. 커진 전립선이 요도를 눌러 불편한 소변 증상을 유발합니다. BPH는 암이 아니며 암을 일으키지도 않습니다. 생활 습관 교정부터 약물, 수술까지 효과적인 치료법이 다양합니다.

이 질환에 대하여

전립선은 요도 상부를 둘러싸고 있습니다. 전립선이 커지면 요도를 압박하여 **하부요로증상(LUTS)**을 유발합니다:

- 약하거나 느린 소변 줄기, 배뇨 지연, 힘주어 소변 봄, 단속뇨
- **잔뇨감** 및 배뇨 후 소변이 계속 떨어지는 증상
- 빈뇨, 절박뇨, 야간에 깨서 소변을 보는 증상(야간뇨)

왜 중요한가요

BPH는 주로 **삶의 질**과 관련되지만, 증상이 심하면 요로감염, 방광결석, 소변을 전혀 볼 수 없는 상태(요폐), 드물게는 방광·신장 손상으로 이어질 수 있습니다. 증상이 일상생활에 얼마나 영향을 주는지에 따라 치료 강도를 결정합니다.

용어 설명

BPH

전립선비대증 — 비암성 전립선 비대.

LUTS

하부요로증상 — BPH로 인한 소변 관련 증상.

IPSS

증상 점수 — 증상이 얼마나 불편한지 측정하는 설문.

요폐

소변을 전혀 볼 수 없는 상태 — 즉각적인 치료가 필요합니다.

알파 차단제 / 5-ARI

BPH 치료에 쓰이는 두 가지 주요 약물군.

PSA

전립선 혈액 검사 — 진단 과정에서 자주 시행합니다.

반드시 치료해야 하나요? 증상이 불편할 때만 치료합니다 — 경증은 경과 관찰로 충분합니다. 증상이 일상에 영향을 준다면 생활 습관 교정 → 약물 → 시술 순으로 단계적으로 치료하며, 각 단계마다 효과적인 방법이 있습니다. 치료 방법은 전립선 크기에 따라서도 달라지며, 의료진이 평가합니다.

진단 방법

- 증상 점수(IPSS)와 수분 섭취량·복용 약물 검토
- 전립선 직장 수지 검사, **소변 검사**, 그리고 대개 **PSA** 검사
- 요속 측정 및 잔뇨량 확인

치료 방법 (단계별)

- 1 **경과 관찰 & 생활 습관 교정** — 저녁 수분 섭취 줄이기, 카페인·알코올 제한, 방광 습관 개선.
- 2 **약물 치료** — **알파 차단제**(빠른 증상 완화), **5-알파 환원효소 억제제**(전립선 크기 축소), 또는 병용; 경우에 따라 다른 약물 추가.
- 3 **최소 침습 시술** — 전립선 요도 리프트(전립선 거상술), 수증기 치료 등.
- 4 **수술** — TURP, HoLEP, Aquablation, 또는 대형 전립선에는 단순 전립선 절제술. 각 수술에 대한 별도 안내문이 있습니다.

알아 두세요

- BPH 치료는 **본인의** 불편감 정도에 따라 결정합니다 — 합병증이 없다면 서두를 필요가 없습니다.
- 일부 감기약·알레르기약(총혈 완화제)은 증상을 악화시킬 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 갑자기 소변을 전혀 볼 수 없는 경우(통증, 방광 팽만) — 응급
- **혈뇨**, 발열, 또는 반복적인 요로감염
- 치료 중에도 증상이 악화되는 경우

기억할 세 가지

1. BPH는 전립선이 비암성으로 커져 소변 줄기 약화와 빈뇨를 일으키는 흔한 질환입니다.
2. 불편감 정도에 따라 생활 습관 교정 → 약물 → 최소 침습 시술·수술 순으로 치료합니다.
3. 갑자기 소변을 볼 수 없거나 혈뇨, 발열, 반복 감염이 있으면 즉시 진료를 받으세요.